Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 19ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810331

Processo nº **0121133-35.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): L. F. D. S.
REPRESENTANTE: CASSANDRA FIGUEREDO DA SILVEIRA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos etc.

1. Cuida-se de **ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos** morais movida por **LUKAS FIGUEIREDO DA SILVEIRA**, menor, representado por sua genitora, **Cassandra Figueiredo da Silveira**, em face de **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, objetivando, em síntese: **(i)** o custeio integral do tratamento da CID 10: F32 + F90.0 +F91.3 (episódios depressivos, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Distúrbio Desafiador e de Oposição), consistente em fisioterapia (mensal), psicólogo (duas vezes por semana), terapeuta ocupacional (uma vez por semana) e psicopedagogo (uma vez por semana), especificamente, conforme laudo médico, **inclusive liminarmente**; e **(ii)** indenização por danos morais.

1.1. Aduziu ela, parte DEMANDANTE, para tanto, em síntese: **(i)** é beneficiário do plano de saúde da parte DEMANDADA, estando adimplente com suas obrigações contratuais; **(ii)** realiza acompanhamento psiquiátrico devido aos transtornos de CID 10: F32 + F90.0 +F91.3 (episódios depressivos, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Distúrbio Desafiador e de Oposição); **(iii)** diante do agravamento do seu quadro, seu médico assistente prescreveu: fisioterapia (mensal), psicólogo (duas vezes por semana), terapeuta ocupacional (uma vez por semana) e psicopedagogo (uma vez por semana); **(iv)** por não ter condições de arcar com o tratamento de forma particular, requisitou, através de notificação extrajudicial, o custeio do tratamento pela parte DEMANDADA; e **(v)** não obteve resposta da parte DEMANDADA.

1.2. Junto à inicial, vieram documentos, dos quais se destaca a carteira do plano de saúde (**ID 186161659**), o contrato firmado entre as partes (**ID 186161662**), o comprovante de pagamento das mensalidades (**ID 186161664**), a notificação extrajudicial (**ID 186161667**) e o laudo médico (**ID 186161667**).

2. Custas processuais e taxa judiciária pagas, conforme **IDs 186443313, 188931160 e 188931169.**

3. Por via do **despacho de ID 187153528**, este juízo inverteu o ônus da prova em desfavor da parte DEMANDADA e determinou a citação e intimação da parte DEMANDADA para se manifestar acerca da tutela de urgência pretendida.

4. A parte DEMANDANTE atravessou a petição de **ID 190052381**, através da qual informou ao juízo que houve piora no seu quadro clínico - inclusive com tentativa de autoflagelação - e requereu, ao fim, a procedência do pedido de tutela de urgência.

5. A parte DEMANDANTE apresentou manifestação de **ID 190058394**, através da qual alegou, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência.

6. **Citada**, a parte DEMANDADA apresentou **contestação de ID 191400552**, acompanhada de documentos de mérito, na qual, **em sede de preliminar**, arguiu a ausência de interesse processual, pois a Res. 541/2022 da ANS incluiu a cobertura dos procedimentos solicitados no rol de procedimentos e eventos em saúde. **No mérito**, em síntese, argumentou, **de forma conflitante com a preliminar acima noticiada**, que: **(i)** o tratamento requerido possui expressa exclusão contratual, por não constar no rol da ANS; e **(ii)** subsidiariamente, existe clínica/profissionais aptos a atender a parte DEMANDANTE na rede credenciada e eventual reembolso deve ser limitado ao estabelecido no contrato firmado entre as partes.

7. Réplica de **ID 193751088**.

8. Eis o relatório, em síntese. Conclusos os autos, **FUNDAMENTO e DECIDO:**

9. De saída, com relação à preliminar de ausência do interesse de agir, entendo que não merece prosperar. Isto porque na própria contestação, a parte DEMANDADA alega a não obrigatoriedade de custeio do tratamento, o que se configura como recusa inequívoca e, por tabela, consubstancia a necessidade de a parte DEMANDANTE buscar amparo judicial. Por este motivo, **REJEITO a preliminar de ausência do interesse de agir arguida pela parte DEMANDADA**.

10. Quanto ao **aspecto formal**, o presente feito seguiu os seus trâmites legais previstos nos arts. 319 e seguintes, do Código de Processo Civil, e, a seu turno, encontra-se em ordem, nada havendo para ser regularizado, uma vez que se encontram presentes as condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes) e os pressupostos processuais (de existência e validade).

11. Ademais, observo que a hipótese é de **resolução imediata do mérito**, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto à matéria nele ventilada é unicamente de direito, prescindindo, pois, de produção de outras provas para o seu desfecho, estando o processo já devidamente instruído com a prova documental a ela carreada, de modo que se mostra autorizado o julgamento no processo no estado em que se encontra.

12. No que se refere às **questões de fundo trazidas a cotejo judicial**, estou convencido, à vista das manifestações das partes durante a marcha processual, de que **não há controvérsias quanto à existência da relação contratual entre as partes**.

13. **A controvérsia, na espécie, reside na responsabilização ou não da parte DEMANDADA em cobrir e custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do menor parte DEMANDANTE**, nos exatos termos do **laudo de ID 186161670**; no que, entendo, **melhor razão assiste à parte DEMANDANTE**.

13.1.Com efeito, é dever da parte DEMANDADA prestar a cobertura necessária para a realização do tratamento de que necessita o menor DEMANDANTE, conforme **prescrição do seu médico assistente (ID 186161670)**.

13.2. Deveras, é firme o entendimento de que não cabe às operadoras de saúde apenas limitarem o tratamento das doenças cobertas pelo contrato, uma vez que cabe ao médico assistente e, não, a elas a prescrição do tratamento adequado, **sendo abusiva cláusula em sentido diverso**.

13.3. Bem por isso, tenho a convicção de que **o médico assistente é quem detém a capacidade técnica e é o conhecedor do quadro clínico do paciente**. Portanto, a sua prescrição deve ser atendida no tocante aos tratamentos médicos e terapêuticos; sobretudo porque se trata de situação que se reveste, inclusive, de **caráter emergencial**, sob o risco de causar prejuízos irreversíveis à parte DEMANDANTE, comprometendo o seu desenvolvimento físico e psíquico.

14. Nesta mesma linha, tenho também partilhado da compreensão no sentido de que **a cobertura necessária para fins de realização do tratamento de que necessita o paciente deve ser prestada na forma indicada pelo seu médico assistente e, também, por clínicas e profissionais aptos a desenvolverem os métodos indicados**. De outro modo, não se alcançaria a prestação do serviço de forma adequada ao consumidor.

15. Tem-se, ainda, o entendimento dos tribunais brasileiros de que o **Código de Defesa do Consumidor e a legislação esparsa que regulam as relações de consumo são aplicáveis aos contratos de planos de saúde (CF, art. 5º XXXII)**.

15.1. Destarte, a sua interpretação, em casos tais do que ora se apresenta – em que, anote-se, se faz presente uma relação de consumo (prestação de serviços de saúde) –, deverá ser levada a efeito na conformidade com os dispostos nos arts. 2º e 3º do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, c/c o arts. 15 e 16, n. IV, da Lei n. 9.656/98.

16. Ademais, **entendo que a cobertura, ora em discussão judicial, deve ser prestada, PRIORITARIAMENTE, por meio declínicas e prestadores credenciados**, ressalvada a hipótese excepcional de comprovação nos autos das incapacidades operacionais e das inaptidões das clínicas e dos profissionais credenciados no atendimento ao tratamento prescrito, o que, contudo, **não vislumbro no caso em liça**.

17. Reforço, inclusive, que, *mutatis mutandi*, o entendimento aqui perfilhado, encontra albergue na jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive desta E. Corte de Justiça pernambucana, conforme dão conta os vv. acórdãos cujas ementas adiante se seguem transcritas, *in verbis*:

> EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO CONTINUADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL . REJEITADA. TRATAMENTO DENTRO DA REDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERESSE DE AGIR . ROL DA ANS. CDC. CÓDIGO CIVIL. PERIGO DA DEMORA INVERSO . AGRAVO DESPROVIDO. 1 – Há nos autos laudos médicos onde foi prescrito acompanhamento multidisciplinar com terapias específicas à criança, diagnosticada com TDAH (CID 10- F90.0), em associação transtorno especifico de leitura e escrita (CID 10- R480), tendo sido prescrito restando destacada a urgência da intervenção. 2 – Diante da necessidade de que o tratamento ocorra de forma continuada, não foi fixado termo final, o que sabidamente depende da avaliação médica, de acordo com a evolução e necessidades do paciente, não se tratando de pedido com natureza genérica, futura e indeterminada . Afastada a alegação de inépcia da inicial. 3 – Embora sustente possuir em sua rede os serviços buscados, a seguradora recusou a cobertura para parte do tratamento, dizendo não estar obrigada a tanto, no que restam configurados a pretensão resistida e o interesse de agir. 4 – Se o contrato não exclui a doença, não pode o plano de saúde obstar ou restringir o acompanhamento prescrito. Ademais, a decisão agravada determinou que o serviço fosse prestado dentro da própria rede credenciada, inexistindo razão para a recusa . 5 – A não inserção de um procedimento no rol da ANS não afasta o dever de cobertura, tratando-se de lista exemplificativa onde não constam todos os serviços a serem cobertos pelas operadoras. Ademais, o próprio STJ considera a taxatividade mitigada do rol, reconhecendo o dever de cobertura quando o tratamento prescrito pelo médico não encontra substituto terapêutico. 6 – Aplicáveis o CDC (arts. 47 e 51, IV) e as normas civis em matéria contratual (boa-fé objetiva e função social do contrato), além de merecerem destaque o direito à saúde e a dignidade humana, os quais se sobrepõem ao interesse econômico da empresa, que, acaso vencedora na lide, poderá, inclusive, buscar reaver valores devidos . 7 – Cumpre, em sede de cognição sumária atentar para os riscos impostos ao resultado útil do processo, ainda mais quando se está diante de tratamento para criança, a qual pode ver agravada a sua situação acaso privada da cobertura do plano para realização do tratamento indicado, o que configura o perigo da demora inverso 8 – Recurso DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0032158-89.2024.8 .17.9000, acordam os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade e na conformidade da ata de julgamento e nos termos do voto do Relator, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da seguradora. Recife, data conforme certificação digital. Desembargador Bartolomeu Bueno RELATOR ?
>
> *(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00321588920248179000, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 21/10/2024, Gabinete do Des . Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)*

> EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INFANTE PORTADOR DE TDAH (CID10 - F90) E TRANSTORNO DISRUPTIVO DA INFÂNCIA (CID10 - F91.3). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE CUSTEIO

SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS . IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. LEI N° 14.454/22 . INCIDÊNCIA DO CDC (ART. 51, IV) E DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO POR EQUIPARAÇÃO DAS BALIZAS FIXADAS NO IAC N° 0018952-81.2019 .8.17.9000 DO TJPE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA CONDENATÓRIA. VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO . RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Negativa de cobertura pelo Plano de saúde tratamento multidisciplinar para criança portadora de TDAH (cid10 - f90) e Transtorno Disruptivo da Infância (cid10 - f91.3). 2. Alegação de que o tratamento não está previsto no rol da ANS afastada, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo, conforme definido pelo Art . 10, § 12 e § 13 da Lei nº 14.454/22. 3. Possibilidade de cobertura de tratamento fora da rede credenciada, desde que não oferecido na rede própria e com a comprovação de que o profissional atende aos requisitos necessários para o acompanhamento do paciente . 4. Utilização por equiparação das balizas fixadas no IAC Nº 0018952-81.2019.8 .17.9000, que tratou sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde providenciarem o tratamento multidisciplinar para portadores de autismo, aos infantes acometidos pelo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), dada a similitude de terapias necessitadas em ambos os casos. 5. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico pelo plano de saúde possui aferição econômica possível, mediante a mensuração do valor da cobertura indevidamente recusada . Consequentemente, o montante correspondente a essa cobertura deve compor a base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial, em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso do réu conhecido e desprovido . Recurso do autor conhecido e provido por unanimidade de votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco –, à unanimidade de votos, em DAR provimento ao recurso autoral, desprovendo-se o recurso promovido pela parte ré, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que passam a fazer parte integrante deste aresto. P. e I . Recife, data da certificação digital Juiz Elio Braz Mendes Relator Substituto

(TJ-PE - Apelação Cível: 01234434820238172001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 26/09/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TDAH. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA . LIMITAÇÃO DE SESSÕES COM PSICÓLOGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART . 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Insurge-se o plano de saúde contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo beneficiário, no sentido de determinar que a ré/agravante autorize e custeie as consultas com psicólogos para o autor, sem limitação de sessões . 2. Conforme o protocolo clínico aprovado pelo Ministério da Saúde, em 03/08/2022, por meio da Portaria Conjunta nº 14, de 29 de junho de 2022, o tratamento do TDAH, assim como a maioria dos distúrbios neurocomportamentais, demanda a atuação conjunta do profissional médico da área da psiquiatria com psicólogo, fonoaudiólogo e educador, entre outros especialistas, a depender do caso. 3. Na reunião extraordinária realizada no dia 11/07/2022, a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas . 4. Resta comprovada a indicação médica para que o autor receba o atendimento psicológico, uma vez que a avaliação neuropsicológica para TDAH é aplicada por um psicólogo com formação em neuropsicologia. 5.Presença dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art . 300 do CPC, de maneira que se revela escorreita a decisão agravada. Súmula 59 do TJRJ. 6. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00633144620228190000 202200286573, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/12/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023)

18. Desta feita, restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de a parte DEMANDADA custear o tratamento prescrito pelo médico assistente da parte DEMANDANTE no laudo médico de ID 186161670.

19. Já com relação ao pedido de danos morais que, também, foi esboçado pela parte DEMANDANTE na sua petição inicial, entendo que ele também merece guarida jurisdicional, diante à negativa abusiva de cobertura, a gravidade da doença e o caráter emergência da solicitação médica, sendo hipótese, no particular, de incidência do enunciado da Súmula n. 035/TJPE:

> *A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.*

19.1. Considerando a demora em prestar a devida cobertura e, ainda, levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e da função punitiva-pedagógica da conduta do infrator, balizando-se, todavia, pela impossibilidade jurídica do enriquecimento sem causa, fixo a quantia de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** para a indenização por danos morais em razão da recusa indevida e negligência da parte DEMANDADA que privou o menor DEMANDANTE do tratamento de que necessitava.

20. Por fim, verifico estarem presentes requisitos autorizadores da tutela de urgência, em conformidade com o art. 300, do Código de Processo Civil. O primeiro deles – isto é, a probabilidade do direito alegado –, diante das razões de fato e direito acima esboçadas. E o segundo e último de tais requisitos – qual seja ele,o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – vislumbro-o presente diante da própria condição de saúde e do desenvolvimento da parte DEMANDANTE, que necessita realizar o tratamento em caráter emergencial, de modo a evitar-se danos irreversíveis ou de difícil reparação à sua saúde e à sua vida.

21. Por tais razões, com espeque nos princípios constitucionais, nos precedentes jurisprudenciais, bem como ditames da legislação do consumidor (Lei nº 8.078/90), e no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO os pedidos formulados na petição inicial, e, por tabela, DECLARO a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos especificados a seguir:

a) DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela parte DEMANDANTE, o qual CONFIRMO nesta mesma oportunidade, e, mais, DETERMINO, como DETERMINADO fica, que **a parte DEMANDADA, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o tratamento prescrito pelo médico-assistente da parte DEMANDANTE exatamente nos termos do laudo médico de ID 186161670, preferencialmente na rede credenciada dela, parte DEMANDADA**; e

b) CONDENO a PARTE DEMANDADA, a pagar à parte DEMANDANTE, indenização por danos morais, no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** com atualização pela tabela do ENCOGE a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês, estes últimos incidentes desde a citação.

22. Em caso de descumprimento, fica, desde já, **autorizada a expropriação de bens e valores da parte DEMANDADA**, para realização do tratamento em clínica particular, devendo, para tanto, a parte DEMANDANTE apresentar três orçamentos, dos quais será escolhido o de menor valor.

23. Em homenagem ao princípio da sucumbência, CONDENO também a parte DEMANDADA ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte DEMANDANTE, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em danos morais e, mais, pelo acolhimento da obrigação de fazer de trato continuado, fixo, também, em 10% do valor da causa, conforme entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp n. 1.746.072.

24. Em sendo interposto recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, se manifestar, no prazo legal, e após, com ou sem a sua manifestação, **REMETAM-SE** os autos ao e. Tribunal de Justiça de Pernambuco, com para processamento e julgamento.

25. Cientifique-se o Ministério Público da prolação desta sentença.

26. PUBLIQUE-SE,INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, como devido.

Recife, 14 de março de 2025

JOSÉ RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JOSE RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA
14/03/2025 12:30:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 197770235

25031412302974300000192718732

IMPRIMIR GERAR PDF